

对医院用药中药物相互作用问题的思考

史国兵^{1,3*}, 黄泰康², 任天舒³ (1. 沈阳药科大学工商管理学院, 沈阳市 110016; 2. 国家食品药品监督管理局, 北京市 100810; 3. 沈阳军区总医院药剂科, 沈阳市 110016)

中图分类号 R952;R696.3 文献标识码 C 文章编号 1001-0408(2009)14-1119-02

摘要 目的:提高对药物相互作用的认识,促进合理用药。方法:对我国医院用药中药物相互作用存在的问题进行分析。结果与结论:我国对合理用药中的药物相互作用认知度较低,需从多角度加强药物相互作用研究;转变认知理念,引起各级政府部门和医药人员重视;推行临床药师制,重构药学服务模式;拓宽研究领域,加强药物相互作用机制和中西药相互作用研究;加快信息化建设,组建药物相互作用数据库;扩大普及教育,提高社会公众的药物知识等。

关键词 合理用药;药物相互作用;问题;思考

Considerations on Drug Interaction Problems in Hospital

SHI Guo-bing (School of Business Administration, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China)

HUANG Tai-kang (State Food and Drug Administration, Beijing 110810, China)

SHI Guo-bing, REN Tian-shu (Dept. of Pharmacy, Shenyang Military Region General Hospital, Shenyang 110016, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To enhance our understanding on drug interactions and promote rational drug use. METHODS: The problems of drug interactions appeared in rational use of traditional Chinese medicines in our hospital were analyzed. RESULTS & CONCLUSION: People in China had a poor cognition on drug interactions in rational use of traditional Chinese medicines, and the drug interactions should be studied from multiple angles, meanwhile, our cognition concept should be changed and the concerned government and medical personal should attach great importance to this matter; clinical pharmacist system should be pushed forward and pharmaceutical service mode should be reconstructed; research on drug interactions should be broadened and research in mechanism of action of drug interactions as well as the interactions between traditional Chinese medicine and western medicines should be strengthened; construction of information should be sped up and database of drug interactions should be set up; propagate education should be emphasized to elevate people's knowledge on medicine etc.

KEY WORDS Rational drug use; Drug interaction; Problems; Consideration

一是必须明确是因感冒引起的咳嗽,符合《治疗指南》的相关规定并伴咳嗽的患者,方可采用此方法;二是排除其他病因,包括患有高血压服用血管紧张素转换酶抑制剂者,以及急性支气管炎、急性鼻窦炎、过敏性鼻炎、慢性支气管炎急性发作、支气管哮喘、细菌性鼻窦炎及咳嗽变异型哮喘、鼻后滴流综合征、嗜酸粒细胞性支气管炎、胃-食管反流性咳嗽患者;三是因咳嗽程度不同,可适当变换上述4条自愈原则,须灵活掌握。

4.5 感冒咳嗽自愈方法的优势

一是此方法相对安全,易掌握推广、普及。二是根据与治疗组的分析判断,本方法用药少,侧重护理便可达到自愈目的。《治疗指南》明确指出,咳嗽明显者可选用中枢性镇咳药,如右美沙芬或可待因等。而笔者在从事咨询服务的过程中,从未应用过此类药,效果依然理想。因此,笔者认为,若继续开展此项工作,将使药师在医疗行业减少药物滥用和药源性疾病,在合理用药方面作出贡献。三是本方法的整个过程费用低,可节省医疗资源。四是某些限制性药物如可待因目前纳入麻醉药品管理,应用不方便,特别是在偏远地区更是如此;右美沙芬现在市

面仅有口服糖浆剂型,大多数人对此药并不了解,未选用此药,且以上2药均属中枢性镇咳药,应用不当会带来一定的副作用,不经医师指导,患者不会轻易选用^[5,6]。如果2种方法同时交待给咨询者,说明其作用相同,一次只可选择一种方式,结果绝大部分咨询者选自我护理加少量给药的自愈方法。究其原因,均反映其有安全感,既方便又经济。

参考文献

- [1] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 咳嗽的诊断与治疗指南(草案)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2005, 28(11): 6.
- [2] 卫生部, 国家中医药管理局. 医疗机构药事管理暂行规定[J]. 中国医院用药评价与分析, 2002, 2(1): 58.
- [3] 韩晋, 吴荣荣. 我院现代化药房建设工作的尝试[J]. 中国药房, 2007, 18(34): 2 669.
- [4] 蔡柏蔷主编. 呼吸内科学[M]. 第1版. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2005: 5.
- [5] 张石革主编. 药师咨询常见问题解答[M]. 第2版. 北京: 化学工业出版社, 生物·医药出版分社, 2008: 129.
- [6] 汤光主编. 临床药学百科[M]. 第1版. 北京: 化学工业出版社, 2006: 273.

(收稿日期: 2009-01-16 修回日期: 2009-03-03)

*主任药师。研究方向: 临床药学。电话: 024-28856162。E-mail: sysgb@126.com

调查^[1]表明,在住院患者中,每日用药1~5种,潜在药物相互作用发生率为12.1%,实际药品不良反应(ADR)发生率为3.5%;用药6~10种,潜在相互作用发生率为29.0%,实际ADR发生率为10.0%;用药11~15种,潜在相互作用发生率为44.8%,实际ADR发生率为28.0%;每年因药物相互作用的致死率,在住院患者致死原因中列第4~6位。因此,提高对药物相互作用的重视迫在眉睫。

1 对我国医院用药中药物相互作用问题的分析

1.1 相关政府部门重视不够

在医疗中,尽管药物相互作用发生率很高,但有临床症状或意义的药物相互作用发生率还是相对较低的。而且,药物相互作用的临床表现通常是以ADR的形式出现的,易被普通的ADR现象所掩盖;药源性损害的临床表现被患者疾病的临床症状所掩盖,可因患者服用的其它药物所改善或缓解。因此,药物相互作用往往无法引起政府相关部门重视。

1.2 医师药理知识的缺乏及分科过细

随着医学的发展,分科越来越细,在三级以上大医院,往往以器官、系统分科,科内又分专业小组,各专科医师之间交流、沟通很少,尤其是中医和西医之间,相互交流和沟通很少。患者多科看病,各科开各科的药,容易导致药物相互作用出现。

1.3 我国医师合并用药品种多

目前,我国住院患者平均每日合并用药5种,不合理用药发生率达21.8%,相对肯尼亚3.1种,我国医师用药量偏大^[2]。笔者认为,其动因与处方者(医师)在我国医疗体系中拥有用药决定权,且受经济利益驱动分不开。

1.4 临床药学模式不完善

随着医院药学服务模式的改变,药师已从窗口后面走了出来,由单纯发药转变为直接面向患者服务。但目前,我国临床药师非常缺乏,且很多药师自身学识不够,使得对患者的用药指导不够,加之新药层出不穷,也使医药工作者应接不暇。这使得我国医院无法顺利开展临床药学工作。

1.5 开展药物相互作用研究起步晚

尽管药物的相互作用影响问题不容忽视,但是由于我国临床药师缺乏,药物相互作用研究起步晚,当遇到由药物相互作用引发的ADR时,往往由医师而非临床药师来判断,他们一般会误以为是病情所致。究其原因,一是医师无法承担合理用药指导工作,面对药物相互作用无能为力;二是现行药物相互作用的研究无法跟上新药的层出不穷的出现速度。

1.6 不重视中药与西药之间的相互作用

随着中西医结合的深入发展(也是我国特色),中西药联用治疗疾病已成为重要的治疗手段,并呈现日益增加的趋势。但中西药合用同样面临药物相互作用,需引起重视。

2 提高对医院用药中药物相互作用认识的对策

2.1 改变知识理念,引起各级政府部门和医药人员的重视

全球约有1/3的患者死于不合理用药,而非疾病本身^[2]。因药物相互作用而引发不合理用药将会变得越来越突出,这不仅违反合理用药原则,还造成国家医药资源的极大浪费。而且,医疗行为是一项充满风险的职业,随着患者自我保护意识的增强,不可忽视因不合理用药引发医疗纠纷所带来的社会问题。因此,各级政府部门应重视药物相互作用,加大人力和资源投入。对于医药人员来说,不仅要思想上加强防范意识,更重要的要加强药物相互作用相关专业知识的学习,加强对新药的药理、药效学特性的学习,注意他学科相关领域的知识面的增容。

2.2 重构药学服务模式,推行临床药师制

《医疗机构药事管理暂行规定》第17条规定^[3],我国将逐步建立临床药师制,这为我国医院临床合理用药提供了制度保障。随着临床药学服务的制度变化,其相应临床药学服务模式也需重构。在新的临床药学服务模式下,临床药师应深入临床一线,与医师一道共同探讨用药方案和药物相互作用等问题,并加强与医师、护士和患者沟通,共同开展合理用药,利用有益的相互作用,避免不利的相互作用。为此,临床药师需加强学习,不但要熟悉和掌握中药与各种西药的药理性能及其相互作用的规律,还要努力学习临床医学知识和心理学、经济学等知识。

2.3 拓宽研究领域,加强药物相互作用机制研究

药物相互作用要真正得到重视,亟需理论指导。而临床药学的理论离不开科学实验,探讨药物相互作用发生的实质与规律,已成为迫切需要进行研究的问题。目前,虽已有一些探讨相互作用方面的方法学研究出现,如采用高效液相色谱法对体液中药物代谢物的测定等,但方法仍然不多,掌握者寥寥。因此,必须加强进行药物相互作用机制的基础研究,尤其加强对肝药酶的研究、对p-糖蛋白的研究、与血浆蛋白结合药物之间的相互作用研究、将药动学和药效学相结合进行研究,以及积极开展体外试验进行药物相互作用预报等。同时,加强中西药相互作用的基础研究,因为中西药治疗所遵循的是不同的理论体系,二者合用必然会带来很多未知的反应。

2.4 加快信息化建设,组建药物相互作用数据库

药物相互作用的研究可为合理用药提供理论依据,医院信息化建设和组建药物相互作用数据库是合理用药的工具。目前,市场上的药品品种成千上万,而且同种药品不同剂型的药品存在不同的作用机制,借助计算机软件设计合理利用相互作用的用药方案有着非常重要的意义。比如,进口的专用药物相互作用软件CoDrug,可进行多药联用时优选最佳组分、剂量和比例的权重配方,用参数法、多指标综合分析法和映射法来分析药物相互作用动态规律,可列出系统研究药物相互作用动力学的完整方案。为了减少医疗费用上涨的压力,有必要借鉴美国成熟的工作方法和丰富的实践经验,结合我国的实际情况,迅速开发并推广符合我国国情的药物相互作用计算机审查系统。

2.5 扩大普及教育,提高社会公众的药物知识

目前,我国每年因ADR而产生的药害很多。其中,不少是由于人们缺乏了解药物知识而导致的,这说明我国迫切需要普及医药知识,提高社会公众的药物知识。我国每年投入大量人力物力进行科学普及工作,但合理用药水平的提升却不明显,不能不说这是科普工作的方向出现了误差,尤其是媒体将有限的精力和银幕资源放在报道医、患纠纷上,这无益于引导民众正确、合理、有效地使用药物,也不利于和谐医、患关系的构建。因此,政府可通过出台政策鼓励社会各界加强安全用药知识的宣传,引导公众安全、有效、经济地使用药物。

参考文献

- [1] 周元瑶主编. 药物流行病学[M]. 第1版. 北京:中国医药科技出版社,1996:5.
- [2] 柯元南. 重视药物相互作用,保证用药安全[J]. 中日友好医院学报,2006,20(1):3.
- [3] 卫生部, 总后卫生部, 国家中医药管理局. 医疗机构药事管理暂行规定[S]. 卫医发[2002]24号.

(收稿日期:2009-02-09 修回日期:2009-03-09)